

Status 1 : BLS

Brochure BLS

Algorithme CAB :

Appeler 144, Stimulation vocale, douloureuse, Pouls carotidien,

Massage : Bien positionner les mains à hauteur des mamelons, bien relâcher le thorax parce que ça se voit sur l'ordi.

Savoir faire le DD des DRS et des dyspnées aiguës.

Connaitre par cœur le Glasgow scale (peu aussi être demandé au status neuro). Faire un examen glasgow pour le BLS avant de faire la réponse motrice (serrer la main) puis réponse à la douleur. On considère locked in à Glasgow 6 parce que le patient peut ouvrir les yeux. Pas faire le Glasgow au début du BLS. Éventuellement faire si le gars se ranime après le choc pour essayer de trouver l'état post événement.

Status 2 : GALS

Systematique (énumérer ce qu'on gait à l'oral):

Poser trois questions !!

- D'abord la marche. Symétrie, harmonie mouvement, longueur foulée, inclinaison du bassin, marche talon-pointe. Ex : si parkinson, pas de balan des bras et pas de retour rapide sur lui-même, claudication : neurogène, vasculaire, etc, hémiparésie : fauchage des jambes, marche de trendelenbourg : besoin de lever le pied haut à chaque pas
- Inspection :
 - dos (scoliose, etc) avant inspection précise regarder si gors élément choc
 - De dos : Colonne : lordose, cyphose, on regarde les genoux pour flexum ou hyperextension, pieds et chevilles pour déformations, etc
 - De face : Thorax, bassin, épaules, genoux, quadricep, pieds cheville
 - Épaules
 - Crêtes iliaques
 - Muscles
 - Creux poplités (ex : kyste poplitée qui peut se rompre et former un gros œdème enflammé -> on peut aussi faire le DD avec une PVT)
 - Tendon d'achille
 - pieds
 - Rachis : Schober : distance doigts sol et schober inversé, inclinaison colonne, rotation colonne (pas de mesure à prendre, Si l'inclinaison va jusqu'à ce que les mains touchent le genou alors normal)
 - Placer les mains derriere la tête et de tourner les coudes vers l'arrière pour tester les mouvements de l'épaule.

- Examen de la main, palpation, observation atrophie et déformation, demander au patient de vous serrer la main, squeeze test ou on comprime les métacarpes
- Pour la mâchoire, pas obligé de mettre les mains mais pas mal pour sentir

Si pathologique, on finit le Gals en disant qu'on explorera le côté pathologique une autre fois

Status 3 : La main

Os de la main et du poignet à connaître ! Pour les artères, il faut retenir le trajet en gros de l'artère ulnaire et radiale et qu'elles finissent de chaque côté de chaque doigt. Pour les nerfs, savoir ce que font ulnaire, médian et radial pour l'innervation motrice et sensitive. Ulnaire fait la partie sensitive ulnaire du côté ulnaire, radial fait la sensation du côté radial sur le côté dorsal et c'est le médian qui fait sur le côté ventral.

Inspection :

Couleur

Cicatrices

Tuméfactions

Déformations (certaines sont à connaître (boutonnière avec extension de l'articulation phalangienne proximale et une flexion de l'IPP, col de cygne flexion IPP et extension IPP, nodosité au niveau proximal = bouchard et en distal = heberden, mallet finger -> doigt qui tombe, phlegmon de la gaine des fléchisseurs est une infection des tendons dans la gaine synoviale avec main gonflée et bloquée en flexion et impossible de la tendre, rizarthrose, etc et savoir quel nerf est concerné

Hypotrophie

Ongles (psoriasis peut se manifester sur les ongles p.ex)

Plaies -> ne pas être trompé par l'importance de la plaie, une grosse peut n'être pas grave et une petite si.

Palpation :

Palper la main -> chaque phalange, chaque métacarpien, tubercule de Lister, tubercule palmaire du scaphoïde, bord dorsal de la tête ulnaire, processus styloïde et la tête des ligaments de TFCC (triangular fibrocartilage complex)

Pathologie :

Maladie de Dupuytren -> flexum de la métacarpo-phalangienne ou de l'interphalangienne proximale à cause de fibrose

Ténosynovite sténosante : si épaississement de gaine synoviale, formations de nodules, si nodule coincé, on ne peut pas bouger le doigt et si le nodule sort tout d'un coup le doigt a un sursaut (doigt à ressort) que l'on peut palper

Kyste synovial du poignet : excroissance de la capsule articulaire avec une boule

Vascularisation -> savoir si c'est chaud, rouge, bleu, etc, faire test allan

Innervation avec baisse de sensibilité à une plaie ?

Palper les sites douloureux en demandant où il a mal, palper les masses, nodosités, œdèmes, scaphoïde (important car celui qui se fracture le plus fréquemment). -> à la fin

Tests fonctionnels : voir photo

Status 4 : Pédiatrie

Pour les examens complémentaires -> ECG de toute façon et, en général, US Doppler et radio du thorax

Status 5 : Pied et Cheville

Connaitre les os du pied.